

90 minut — inwestycja w terapię

Pierwsza konsultacja decyduje o kierunku leczenia i buduje przymierze. Skrócenie tej oceny kosztuje miesiące w dalszej terapii.

CZAS: 60–90 min, często w 2 sesjach **REALIZACJA:** każdy nowy pacjent z podejrzeniem AN

ŹRÓDŁO: Fairburn (2008, CBT-ED); Waller i in. (2007); NICE (2017, NG69)

JAK UŻYWAĆ

W sekcji 01 — **osiem obszarów** strukturalnej oceny wstępnej. W sekcji 02 — **strukturalny przebieg** sesji 90 min. Sekcja 03 — **twoje przygotowanie**: co warto wiedzieć przed pierwszą wizytą.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Pierwsza konsultacja u pacjenta z podejrzeniem AN decyduje o kierunku leczenia i buduje przymierze. Trzy zadania: **(1) ocena bezpieczeństwa medycznego** (BMI, objawy, badania, MEED próg czerwonej strefy); **(2) ocena psychiatryczna** (komorbidność: depresja, lęk, OCD, ryzyko suicydalne); **(3) zbudowanie przymierza** (MI, nie konfrontacja). Bez bezpieczeństwa medycznego — najpierw stabilizacja; bez przymierza — pacjent nie wróci na drugą sesję.

01 Osiem obszarów oceny — wszystkie muszą być uwzględnione

OBSZAR	ZAWARTOŚĆ
1 · Historia zaburzenia	Początek, przebieg, wagi historyczne, wcześniejsze leczenie, momenty zaostrzenia i poprawy.
2 · Aktualne objawy	Restrykcja, epizody objadania, kompensacje, sprawdzanie ciała, obraz ciała, zaprzątnięcie myśli myślami.
3 · Ocena medyczna	BMI, parametry krążeniowe, miesięczka, EKG, badania laboratoryjne, objawy somatyczne.
4 · Psychospołeczne	Samoocena, funkcjonowanie zawodowe i społeczne, szkoła/praca, relacje, sieć wsparcia.
5 · Komorbidność + ryzyko	Depresja, lęk, OCD, PTSD, używki, myśli samobójcze, samookaleczenia. Priorytet bezpieczeństwa.
6 · Motywacja / wgląd	Czemu się leczę, co chcę zmienić, co powstrzymuje, ambiwalencja.
7 · Formuła kliniczna	Wstępna konceptualizacja CBT-E — indywidualny diagram mechanizmów.
8 · Plan + kontrakt	Model leczenia, częstotliwość, koordynacja medyczna, cele wstępne, oczekiwania.

02 Strukturalny przebieg sesji 90 min

0–10 MIN · KONTEKST

„Co cię tu sprowadza? Kto cię skierował? Co chcesz osiągnąć?” *Nie zaczynaj od wagi. Czas pacjenta.*

25–45 MIN · OBJAWY

Restrykcja, napady, kompensacje, sprawdzanie ciała, obraz ciała. Konkretnie pytania, bez interpretacji.

60–75 MIN · KOMORBIDNOŚĆ

Depresja, lęk, OCD, PTSD, suicyd, samookaleczenia, używki. **Bezpieczeństwo priorytet.**

10–25 MIN · HISTORIA

„Kiedy się zaczęło? Co się działo wtedy w twoim życiu?”
Rekonstruuje oś czasu — zaostrzenia, poprawy.

45–60 MIN · MEDYCZNE

Wagi historyczne, miesiączka, parametry, EKG.
Priorytet MEED.

75–90 MIN · PLAN

Motywacja, formuła, kontrakt, częstotliwość, koordynacja medyczna, oczekiwania.

03 Moje przygotowanie do pierwszej wizyty

MOJA HISTORIA WAG

— *maksymalna, minimalna, aktualna, momenty zwrotne*

WCZEŚNIEJSZE LECZENIA

— *terapeuci, hospitalizacje, leki; co działało, co nie*

OBECNE OBJAWY SOMATYCZNE

— *omdlenia, kołatania, brak miesiączki, osłabienie, sen*

MÓJ SYSTEM WSPARCIA

— *kto wie, kto może pomóc, kogo chcę włączyć w terapię*

Klucz: dobrze przeprowadzona pierwsza konsultacja *oszczędza miesiące* w dalszej terapii. **Priorytet bezpieczeństwa:** oceń aktywne myśli samobójcze, ryzyko medyczne (MEED), samookaleczenia. Gdy kryteria czerwone ($BMI < 13$, bradykardia < 40 , hipokaliemia $< 3,0$) — *natychmiastowa* interwencja medyczna lub SOR. Bezpieczeństwo zawsze ma pierwszeństwo nad strukturą konsultacji. Konsultacja to *budowanie przymierza*, nie tylko zbieranie danych. Pierwsze 10 min to czas pacjenta.

△ U pacjenta z bardzo niskim BMI lub aktywnym ryzykiem suicydalnym konsultacja może wymagać skrócenia na rzecz natychmiastowej interwencji. Linia wsparcia: 116 123 (dorośli), 116 111 (młodzież).